

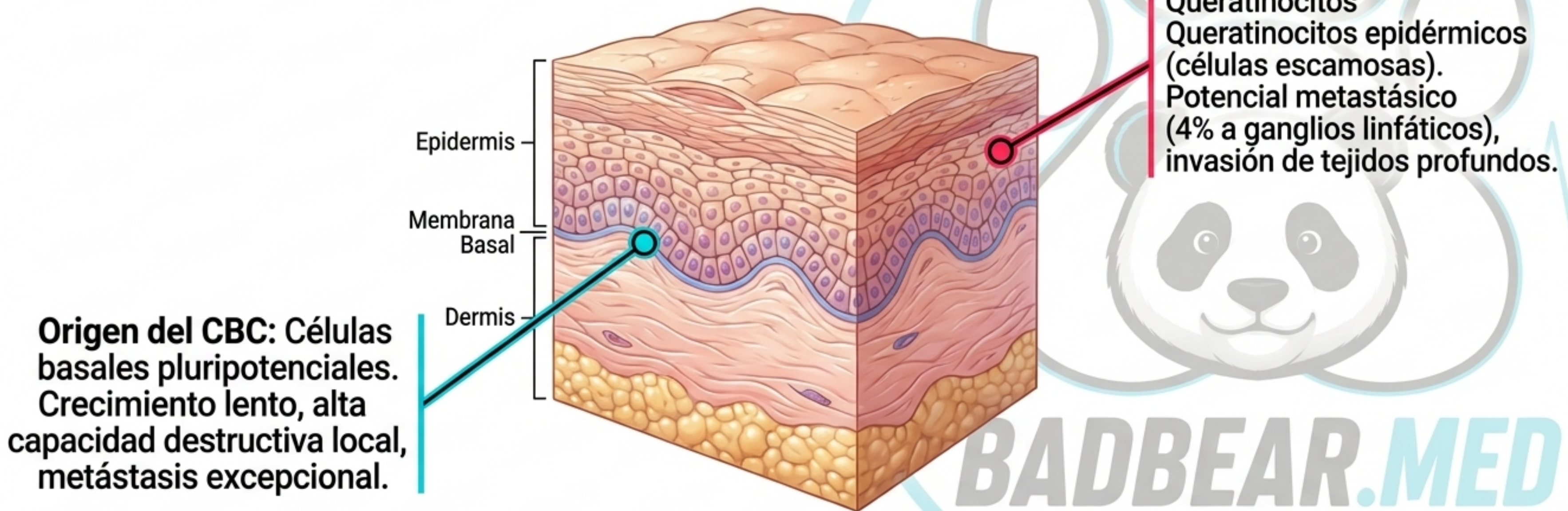


NEOPLASIAS MALIGNAS DE LA PIEL: NO MELANOMA

Carcinoma Basocelular (CBC) y Carcinoma Espinocelular (CEC)

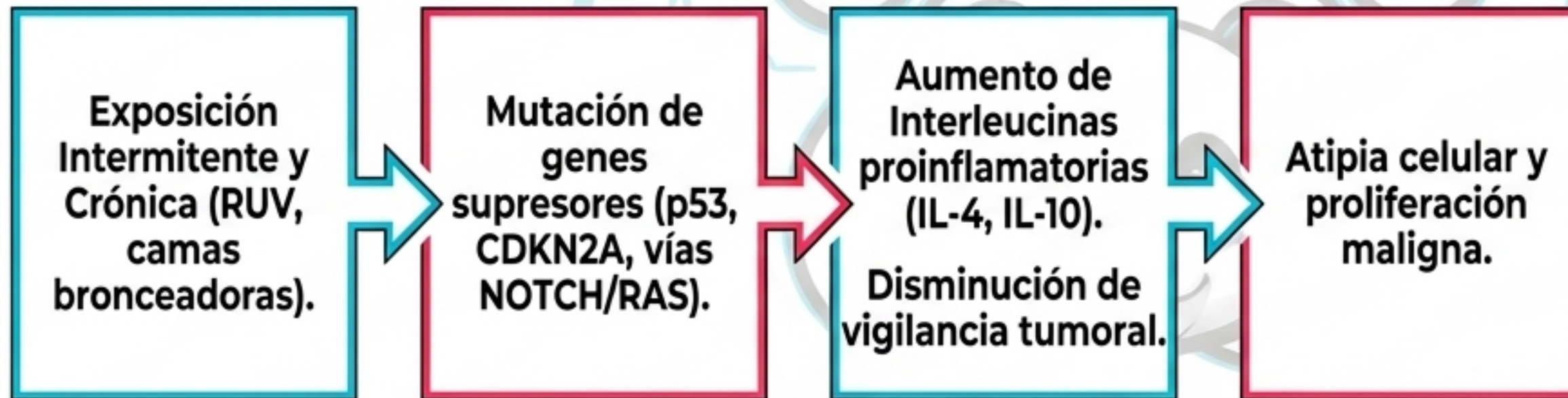
Guía de Estudio Detallada y Matriz Diagnóstica.

Arquitectura del Cáncer Cutáneo



BADBEAR.MED

Patogenia y Factores de Riesgo Compartidos



Factores de Riesgo Genético y Ambiental

Fenotipo:

Fototipos I, II y III.
Albinismo.

Síndromes:

Xerodermia Pigmentosa,
Síndrome de Gorlin.

Tóxicos: Exposición a
Arsénico, Radiación
ionizante/Radón.

CARCINOMA BASOCELULAR (CBC): Perfil Clínico e Histopatológico

Clínica

[IMAGEN REAL: Clinical photo of a classic friable, bleeding CBC lesion]

Cáncer de piel más frecuente mundialmente (6ta-7ma década).
Lesiones friables, sangran al mínimo roce (lavado facial), forman costras que no cicatrizan en meses o años.

Histología

[IMAGEN REAL: Histological slide showing purple basaloid nests]

El Sello Diagnóstico:
“Nidos de células basaloideas”.
Conglomerados de color violáceo con disposición en empalizada invadiendo la epidermis.

Atlas Visual CBC: Variantes Comunes

[IMAGEN REAL:
Nodular CBC]

[IMAGEN REAL:
Superficial CBC
on trunk]

[IMAGEN REAL:
Pigmented CBC]

Nódulo-Ulcerativo

- Variante más frecuente.
- Pápula/nódulo que evoluciona a úlcera central.
- Borde pálido/cerúleo (perlado) con telangiectasias.

Superficial

- Forma más benigna.
- Placa eritematosa y descamativa con pequeñas erosiones.
- Predomina en el tronco.

Pigmentado

- Pigmento focalizado o en bordes (no extravasado como el melanoma).
- Requiere diagnóstico diferencial ABCDE estricto.

Atlas Visual CBC: Variantes Agresivas y Atípicas

[IMAGEN REAL:
Morpheaform CBC]

Morfeiforme / Esclerodermiforme

Forma **MÁS** agresiva e invasiva. Placa hipocrómica/nacarada, indurada (esclerótica), tendencia atrófica y bordes mal definidos.

[IMAGEN REAL:
Infiltrating destructive CBC]

Terebrante / Infiltrante

Altamente destructiva de tejidos blandos profundos, cartílago y hueso. Tendencia a sobreinfección severa y sangrado.

[IMAGEN REAL:
Periorificial Ulcus Rodens]

Ulcus Rodens

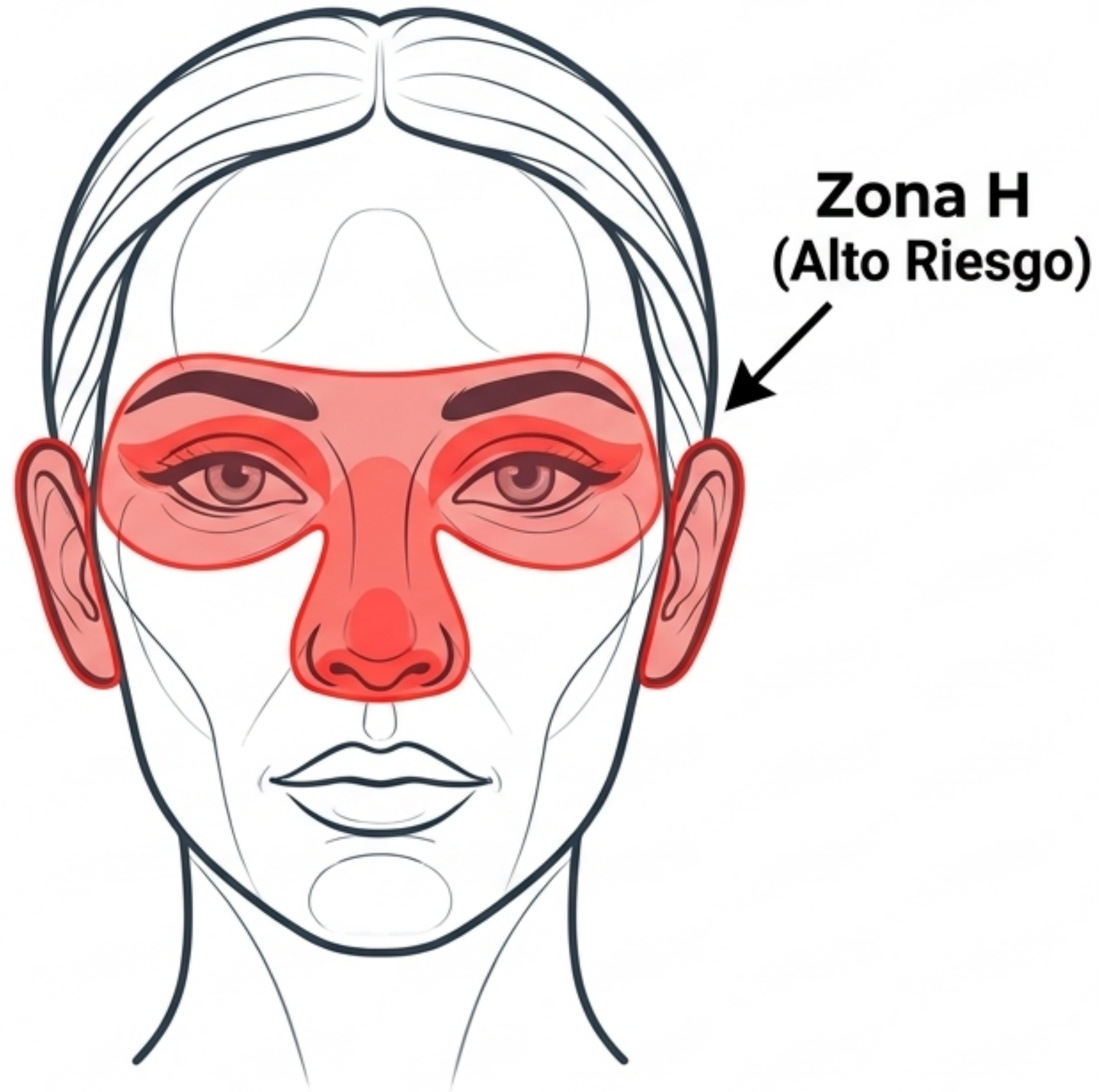
Erosión/úlceras desde el inicio anatómico. Bordes bien demarcados. Frecuente en zonas periorificiales (ojos, nariz, boca).

[IMAGEN REAL:
Pinkus Fibroepithelioma]

Fibroepitelioma de Pinkus

Pápula/placa rosada o marrón claro, a veces pediculada (simula acrocordón). Típica en región lumbosacra, ingles y muslos.

CBC: Zonas de Riesgo y Criterios de Agresividad



Marcadores de Alto Riesgo

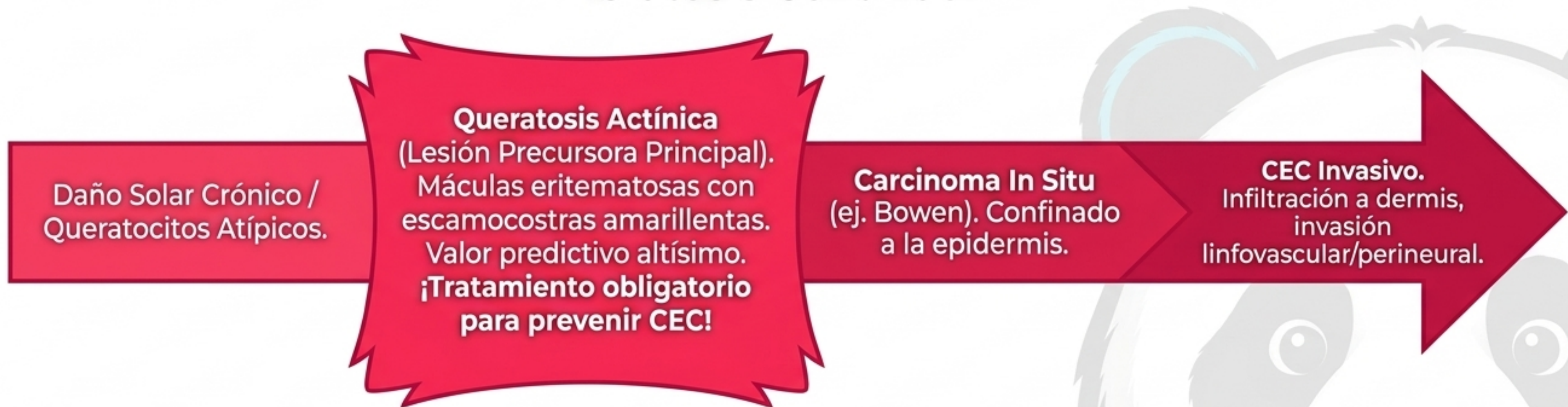
- Tamaño tumoral $>2.5 - 3$ cm.
- Ubicación en Zona H centrofacial.
- Bordes clínicos mal definidos o tumores recidivantes.
- Hallazgo patológico: Invasión perineural o vascular (subtipos morfeiforme o basoescamoso).

Protocolo de Tratamiento

- Extirpación quirúrgica completa (Gold Standard).
- Cirugía Micrográfica de Mohs: Preferida en cara/Zona H para máximo ahorro de tejido estético.
- Alternativas (ancianos/lesiones superficiales): Imiquimod tópico, crioterapia, láser.

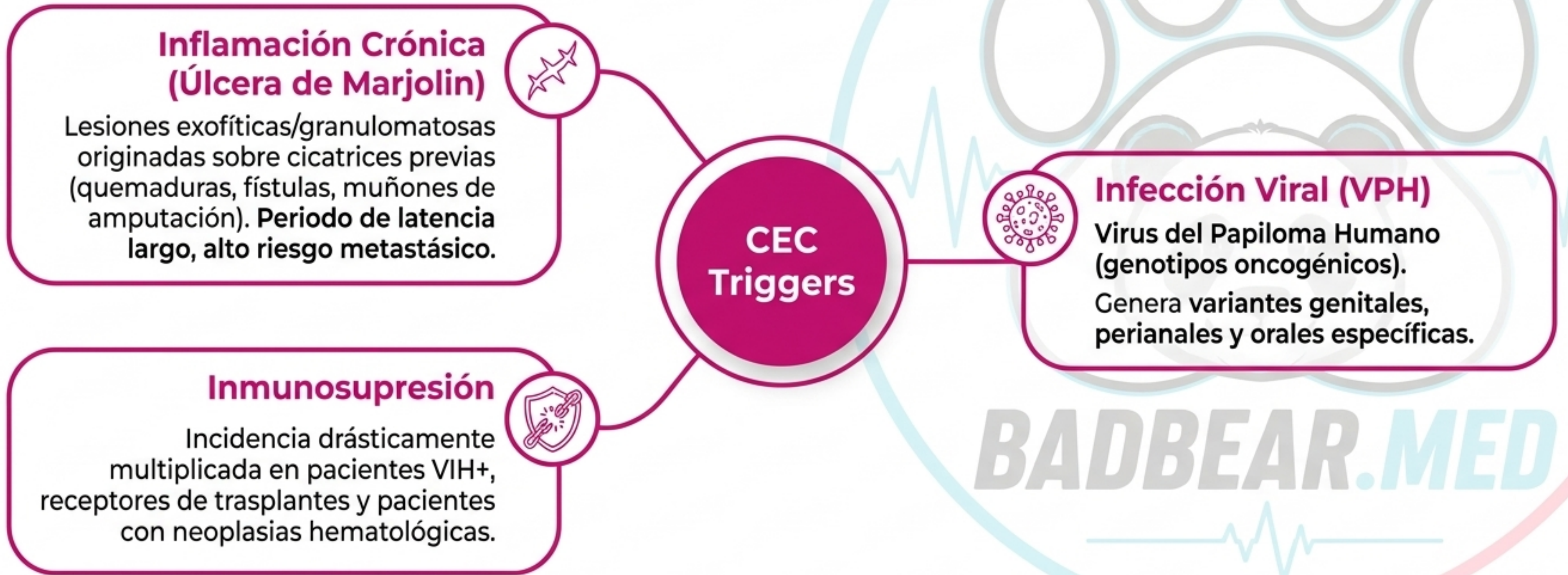
CARCINOMA ESPINOCELULAR (CEC): Perfil y El Continium Precursor

Keratosis Continuum



DATO CLÍNICO: Tasa de supervivencia a 5 años post-cirugía >90%, pero requiere estadiaje obligatorio por potencial de metástasis ganglionar (hasta 4%).

CEC: El Ecosistema de Factores Desencadenantes



Atlas Visual CEC: Morfologías Clásicas

[IMAGEN REAL:
Bowen's Disease
plaque]

Enfermedad de Bowen (CEC In Situ)

- Placa eritematocostrosa única, de crecimiento lento, con bordes policíclicos/mamelonados. Frecuente en tronco y miembros.

[IMAGEN REAL:
Cutaneous Horn]

Cuerno Cutáneo

- Proyección de queratina sólida. El peligro reside en la base (puede ser queratosis actínica o CEC franco). Biopsia de base obligatoria.

[IMAGEN REAL:
Keratoacanthoma]

Queratoacantoma

- Nódulo indurado de crecimiento ultra-rápido. Forma de volcán con un tapón queratósico central masivo.

Atlas Visual CEC: Variantes Mucosas y Especiales

[IMAGEN REAL:
Erythroplasia of
Queyrat]

Eritroplasia de Queyrat / Papulosis Bowenoide

- Variantes genitales vinculadas a VPH. Placas eritematosas de piel brillante (Queyrat) o pápulas rugosas marrón oscuro en adultos jóvenes (Bowenoide).

[IMAGEN REAL:
Verrucous
Carcinoma /
Buschke-Löwenstein]

Carcinoma Verrucoso

- Masas vegetantes exofíticas y destructivas. Buschke-Löwenstein en glánde/genitales; Epitelioma Cuniculatum en región plantar; Papilomatosis Oral en encías/mucosa.

[IMAGEN REAL:
Subungual SCC]

Variedad Subungueal

- Placa escamosa, costrosa o erosiva crónica debajo de la uña. A menudo confundida inicialmente con paroniquia o infecciones crónicas.

CEC: Estratificación de Riesgo y Manejo Clínico



Indicadores Histológicos de Gravedad - Nivel de Clark

Variantes desmoplásicas/adenoescamosas, invasión linfovascular o perineural, y pobre diferenciación celular.

Protocolo Operativo

Biopsia excisional, cirugía convencional con márgenes limpios o Mohs.

Imperativo: Estadaje completo y palpación de ganglios linfáticos.

Seguimiento cada 3-6 meses por 2 años.

LA MATRIZ DEFINITIVA: CBC vs. CEC

CBC		CEC
Células basales epidérmicas	Célula de Origen	Queratinocitos atípicos/escamosos
1º Cáncer más frecuente	Frecuencia Relativa	2º Cáncer más frecuente
Radiación UV exclusiva/Genética	Factor Desencadenante Clave	Radiación UV + Inflamación crónica, Quemaduras, VIH, VPH
Ninguna / De novo	Lesión Precursora	Queratosis Actínica
Nidos basaloideos en empalizada	Sello Histopatológico	Proliferación de queratinocitos atípicos invadiendo dermis
Destrucción local masiva, metástasis excepcional	Comportamiento Clínico	Destrucción local + Riesgo de metástasis ganglionar del 4%
Extirpación sin estadiaje	Requisito de Manejo Único	Estadiaje ganglionar obligatorio

Fotoprotección y Educación al Paciente



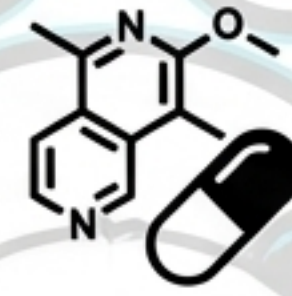
Prevención Primaria

Uso estricto de bloqueadores solares. Evitar exposición máxima (10 AM - 4 PM). Uso de barreras físicas (sombrillas, sombreros, lentes).
Erradicación de camas bronceadoras.



Prevención Secundaria (Vigilancia)

Autoexamen regular de la piel. Educación para identificar úlceras que no cicatrizan o lesiones exofíticas nuevas.
En pacientes post-operatorios: seguimiento dermatológico estricto cada 3-6 meses.



Innovación en Suplementación

Uso de suplementación con Nicotinamida en pacientes con historial previo de cáncer cutáneo para reducir drásticamente las tasas de recidiva y la aparición de nuevas lesiones.



FIN DE LA GUÍA DE ESTUDIO.

PROYECTO BADBEAR.MED.

Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido médico de alto rendimiento y dominar tu formación clínica.



BADBEAR.MED | Facebook • Instagram • YouTube • Rutube • OnlyFans • Telegram • TikTok